BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM

Mã đề xuất CS-TMH-07; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

Mã ICD xác nhận theo chẩn đoán và vị trí; ung thư vòm mũi họng thuộc nhóm C11, không gộp C10 cho mọi ung thư vòm.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

- Hỏi tiền sử gia đình, bệnh có nghẹt mũi, đau họng, khó thở, có khạc ra máu không? Có nghe kém không?

Nhận định triệu chứng, dinh dưỡng và điều trị đang dùng; khám/nội soi, CT/MRI và đánh giá giai đoạn theo bác sĩ. Điều dưỡng không tự chỉ định khảo sát di căn.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1. Bệnh ù tai do khối u

2.2.Bệnh khỏ thở do nghẹt mũi

Nguy cơ thiếu dinh dưỡng, sặc, tổn thương niêm mạc và tác dụng bất lợi điều trị; di căn là diễn biến bệnh cần bác sĩ đánh giá, không phải chẩn đoán điều dưỡng duy nhất.

2.4.Người bệnh thiếu kiến thức về bệnh

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

3.1.Cải thiện tình trạng ù tai

3.2.Cải thiện tình trạng khó thở

3.3.Giảm nguy cơ xảy ra biến chứng

3.4.Cung cấp kiến thức cho người bệnh

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1.Cải thiện tình trạng ù tai:

- Nếu người bệnh ù tai cho uống thuốc theo y lệnh, tư vấn lên tuyến trên theo y lệnh càng sớm càng tốt

4.2.Cải thiện tình trạng khó thở:

Khó thở/thở rít, chảy máu nhiều hoặc giảm ý thức: gọi cấp cứu, đánh giá và hỗ trợ đường thở theo tình trạng; không chỉ kê đầu cao rồi tư vấn tự chuyển.

4.3.Giảm nguy cơ xảy ra biên chứng:

Phối hợp cơ sở ung bướu theo kế hoạch; theo dõi đau, nuốt, lượng ăn/uống, cân nặng, niêm mạc miệng và tác dụng điều trị; lập hỗ trợ dinh dưỡng và kiểm soát triệu chứng theo y lệnh.

4.4.Cung cấp kiến thức cho người bệnh

Giải thích kế hoạch chẩn đoán/điều trị, nơi tiếp nhận và lịch hẹn; không bảo đảm can thiệp sớm sẽ tránh mọi biến chứng.

- Động viên tinh thần cho người bệnh và gia đình

5. Đánh giá

-Người bệnh cải thiện

Đánh giá khả năng thở/nuốt, kiểm soát đau, mức ăn uống/cân nặng, tổn thương niêm mạc và tuân thủ kế hoạch; không lấy hết nghẹt mũi làm tiêu chí duy nhất.

- Bệnh hiểu biết về bệnh

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/appetite-loss/nutrition-hp-pdq. Áp dụng theo đối tượng và hoàn cảnh của hướng dẫn, không thay thế chỉ định bác sĩ hoặc quy định của bệnh viện.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……